

酒与药物相互作用引起的不良反应

徐 旭

[摘 要] 随着经济发展,饮酒已成为人们生活中普遍存在的现象。酒与多种药物会产生相互作用,进而引起不良反应。笔者从酒能影响药物的生物转化及损害胃肠道黏膜、抑制凝血因子、扩张血管、抑制中枢神经、损害肝脏等方面加以阐述,归纳出酒对苯妥英钠、降糖药、三环类抗抑郁药、镇静药、维生素、止血药、利尿降压药、非甾体解热镇痛药、抗变态反应药等的影响,以及戒酒硫样反应,目的是更好地保障人体用药安全,维护身体健康。

[关键词] 酒;乙醇;药物;相互作用;不良反应

有资料显示,我国酒的生产与消费均呈现稳步增长的势头^[1],与酒相关的问题也呈上升趋势,对人体健康产生重要影响^[2]。酒中有效成份乙醇,能通过胃肠道快速吸收并分布到全身体液,主要(90%~98%)经肝脏代谢^[3]。笔者检索了酒对多类西药影响的相关文献,现总结如下。

1 影响药物的生物转化

药物在体内的生物转化,一般是在酶的催化下进行的,体内参与药物代谢的酶主要是肝药酶,它对药物的生物转化产生影响,从而使药物的效应产生相应的变化。

1.1 酒的酶促作用 酒能诱导肝微粒体药物代谢酶,表现为肝内质网增生及药物氧化酶数量增加,药酶活性增强。

1.1.1 苯妥英钠 酒使本品代谢增加,血中有效浓度降低。如在使用本品治疗癫痫期间饮酒,会导致癫痫发作。

1.1.2 胰岛素和降糖药 酒可促进此类药物代谢,引发严重低血糖反应和不可逆的神经系统病变,如头晕、呕吐,甚至精神错乱、平衡失调等。因此,应用降糖药(包括甲苯磺丁脲、瑞格列奈、格列喹酮、格列苯脲、格列齐特、格列美脲、格列吡嗪等)治疗期间应戒酒。

1.1.3 酒还能增强三环类抗抑郁药的不良反应 此类药物按化学结构分为 3 类:吩噻嗪类:氯丙嗪、奋乃静、氟奋乃静、三氟丙嗪、三氟拉嗪、硫利达嗪、乙酰丙嗪等;噻吨类:泰尔登、氨硃噻吨、三氟噻吨、氯普噻吨等;二苯环庚烯类:阿米替林等。

1.2 酶抑作用 长期大量饮酒者易发生肝硬化,出现肝内质网脱粒现象,导致药酶活性降低,产生酶抑作用。

1.2.1 服用镇静药同时大量饮酒,可发生严重的药物中毒,有时可危及生命。因此,服用此类药物(包括地西洋、去甲西洋、哈拉西洋、吡唑酮、硝西洋、氟西洋等)时禁止饮酒。

1.2.2 酒可使单胺氧化酶抑制剂(包括帕吉林、苯乙肼、呋喃吡酮、异唑肼、硫酸反苯丙胺等)作用增强,出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头晕、呼吸困难等严重不良反应。

1.3 抑制非微粒体酶系 非微粒体酶系(常见醇脱氢酶、醛脱氢酶、单胺氧化酶等)存在于胞浆线粒体内和血浆内,可催化药物的氧化代谢。乙醇进入体内后大部分在胞浆内代谢,首先在辅酶 A 作为受体氢参与下,在肝脏醇脱氢酶作用下转化为乙醛,乙醛经醛脱氢酶催化为乙酸,最后氧化为二氧化碳和水。

1.4 戒酒硫样反应 即“醉酒状”反应、双硫醒样反应,国

内关于酒的这一不良反应曾有过多例报道^[4-7]。进入体内的酒在肝脏中转化为乙醛后,药物能阻断乙醛被继续氧化成乙酸,导致体内乙醛蓄积中毒。临床表现:用药后 5~10 min 内即可出现面部发热、面色猩红、头颈部血管剧烈搏动或搏动性头痛,严重者可出现呼吸困难、恶心、呕吐、出汗、口干、胸痛、心跳加快、血压下降、烦躁不安、视觉模糊、精神错乱,甚至休克,其严重程度与用药剂量和饮酒量呈正比。老人、心脏病、脑血管病及对乙醇敏感者反应更为严重,反应剧烈者可致呼吸抑制、心律失常、心肌梗死、急性充血性心力衰竭甚至死亡^[8]。

抢救措施:若出现严重戒酒硫样反应,应立即采取抢救措施,如维持血压、抗休克,必要时人工给氧,静脉输液,给予大剂量维生素 C,补充葡萄糖和维生素 B₁,并注意血钾、血镁浓度,及时纠正低钾、低镁。

此类药物:甲硝唑、替硝唑、头孢哌酮、头孢噻肟钠、头孢孟多、拉氧头孢、头孢曲松、头孢咪诺、头孢噻利、华法令、呋喃唑酮、氯磺丙脲、胰岛素、硝酸甘油、硝酸异山梨酯、异丙嗪、苯海拉明、巴比妥类、氯丙嗪、丙卡巴胂等^[4,6]。还应注意,肝线粒体内的乙醛脱氢酶一旦被抑制,常需 4~5 d 才能恢复,故停用药物 4~5 d 内饮酒,同样可发生此类反应。

2 其他影响

2.1 酒精可损害肠道粘膜,使其运动功能发生障碍,减少叶酸、维生素 B₁、维生素 B₁₂ 的吸收^[9]。因此,维生素缺乏症(如脚气病、多发性神经炎)患者长期饮酒,会特别消耗维生素 B₁ 等,使病情加重。

2.2 酒精可以抑制凝血因子,对抗止血药物,使止血作用大大降低^[9]。

2.3 酒的扩张血管作用对利尿降压药的影响,会使人出现头晕、直立性虚脱等症状^[9]。

2.4 服用含阿司匹林、对乙酰氨基酚等非甾体解热镇痛药,如泰诺、感康、快克、白加黑、百服宁等后再饮酒,可引起黏膜出血,造成急性出血性胃炎。这是因为乙酰水杨酸能抑制具有生理活性的环氧化酶(COX),抑制前列腺素的合成而使胃酸增多,抑制胃肠蠕动,收缩黏膜血管引起局部出血,甚至坏死。而酒则有促进胃液分泌,引起蛋白质变性的作用^[9]。

2.5 酒与药物合用增加对中枢神经的抑制 抗变态反应药:酮替芬、氯苯那敏、氯马斯汀、茶苯海拉明等;镇痛药:舒芬太尼。

2.6 加重肝损害 利福平、红霉素、抗血吸虫药硝硫氰等;

这些药物有很强的肝毒性,与酒合用会使肝毒性加重。

综上所述,酒与多种药物相互作用产生不良反应。用药期间应禁酒或禁用含乙醇的药剂,如氢化可的松、氯霉素等^[10]。医护人员在诊疗过程中,须仔细询问患者用药史、过敏史、饮酒习惯,同时严格掌握用药适应证,对 12 h 内有饮酒史者,宜暂缓用药或用其他药物代替,一旦出现不良反应及时停药,并密切观察,有抢救意识。作为药师更应“以病人为中心”,认真向患者交代药物使用的注意事项,保证患者的用药安全。

参考文献:

[1] Xinhua Net. Guangdong Channel China had become the world 's largest producer of beer since 2002 [EB/OL]. [2004-10-14]. <http://news.xinhua.net.com/newscenter/content-2088880.htm>.
[2] 郝伟,曹栋,于欣.我国饮酒现状及相关问题[J].中国药物依

赖性杂志,2007,16(3):193-197.
[3] 国家药典委员会.中华人民共和国药典临床用药须知.化学药和生物制品卷[M].北京:人民卫生出版社,2005:12.
[4] 于任秋,尹玲.应用头孢哌酮钠后饮酒致过敏反应 30 例临床分析[J].实用药物与临床,2007,10(5):295.
[5] 吕杰,孙小英.头孢塞肟钠治疗停药后饮酒致双硫仑样反应 1 例[J].中华实用药物杂志,2003,7(3):13-14.
[6] 丁凤茹,雷雨晶.饮酒引起先锋必过敏反应 16 例[J].齐齐哈尔医学院学报,2001,22(5):541.
[7] 李俊勇,窦静,王燕舞,等.应用头孢哌酮舒巴坦后饮酒致双硫仑样反应 1 例[J].白求恩医学院学报,2006,4(1):53.
[8] 陈新谦,金光豫,汤光.新编药理学[M].第 16 版.北京:人民卫生出版社,2007:57.
[9] 李钧.可致依赖性药物及其管理[M].北京:化学工业出版社,2006:257-258.
[10] 汤光.临床药理学[M].北京:化学工业出版社,2006:191.

•短篇报道•

注射用头孢曲松钠致血尿二例

刘晶华,贺梅

头孢曲松钠制剂是半合成的第 3 代注射用头孢菌素,临床上主要用于治疗敏感菌所致下呼吸道感染,如肺炎、支气管炎等;腹腔感染,如腹膜炎、胆道及胃肠感染;泌尿生殖系统感染(包括淋病);皮肤软组织感染;骨和关节感染;耳鼻喉感染,如急性中耳炎;手术前预防感染以及其他严重感染,如脑膜炎、败血症。其不良反应与治疗的剂量、疗程有关,本文报道了注射用头孢曲松钠致血尿 2 例的病例。

1 病例资料

病例 1:患者,女,76 岁,患慢性肺心病多年,近日因症状严重在医院就诊,给予注射用头孢曲松钠(山东罗欣药业有限公司,批号:20051205)4.0 g,加入 0.9%氯化钠注射液 250 mL,静滴,1 次/d。2 d 后患者皮肤偶有瘙痒,但无药疹。1 周后患者出现洗肉水样尿,双膝关节出现对称性瘀斑,2 cm×2 cm 大小,双足皮肤出现散在出血点。尿常规:比重 1.018,蛋白(+),红细胞(++++),白细胞(+),红细胞管型(+),尿糖(-),亚硝酸盐试验(-),立即停药。给予口服氨甲环酸片 1 g,扑尔敏片 4 mg,维生素 C 片 50 mg,3 次/d。第 2 天血尿症状缓解,双下肢瘀斑、出血点逐渐消失,连续用药 3 d,症状消失。

病例 2:患者,男,48 岁,因右耳断裂伤到医院就诊,给予注射用头孢曲松钠(西南合成制药股份有限公司,批号:060116)2.0 g,加入 5%葡萄糖注射液 250 mL 静滴,1 次/d。1 周后患者出现畏寒,寒战,尿少伴肉眼血尿,尿常规:比重

1.022,红细胞(++++),白细胞(+)。立即停药,给予维生素 K₁ 片 10 mg,维生素 C 片 50 mg,口服,3 次/d。症状逐渐好转。5 d 后痊愈。

2 讨论

头孢曲松钠在人体内不被代谢,约 40%的药物以原形自胆道和肠道排出,60%自尿中排出。该药不良反应与治疗的剂量、疗程有关。局部反应有静脉炎(1.86%),还可有皮疹、瘙痒、发热、支气管痉挛和血清病等过敏反应(2.77%),头痛或头晕(0.27%),腹泻、恶心、呕吐、腹痛、结肠炎、黄疸、胀气、味觉障碍和消化不良等消化道反应(3.45%)。实验室检查异常约 19%,其中血液学检查异常占 14%,包括嗜酸性粒细胞增多,血小板增多或减少和白细胞减少。肝肾功能异常者为 5%、1.4%。

病例分析有以下原因:①患者属于过敏体质,给药后出现一过性血尿;②患者体质、免疫力差;③头孢曲松钠的配伍禁忌较多;④药物 60%自尿排出,对肾的一过性损害。

出现血尿应采取相应的救治措施:①抗组织胺药物;②止血药物;③及早使用糖皮质激素,用量应以足以控制临床症状为准,症状控制后尽快减量至停药;④预防和治疗感染。综合分析本病例,为减少临床应用头孢曲松钠致不良反应,用药前应仔细阅读说明书,注意不良反应、禁忌和注意事项的内容,掌握好剂量、浓度、滴注速度、疗程,随时进行实验室尿样检查,防止造成严重不良反应。